

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: GUTIERREZ ARGOTE NATALIA	H.C: 1122412827
EDAD: 11 Años	FECHA DE NACIMIENTO: 24/03/2014
ESCOLARIDAD: Sexto grado	FECHA DE EVALUACIÓN: 9,11/10/2025, 12/11/2025
DIRECCION: Calle 2 7 - 04	CORREO: NA
EPS: Salud Total	SEXO: F
ACOMPANANTE: Padre	CELULAR: 3173215778
LATERALIDAD: Diestra	NEUROPSICÓLOGO EVALUADOR: M.G Jainer Guzmán
ESPECIALIDAD QUE REMITE: Neurología	

MOTIVO DE CONSULTA

Aplicación ADOS 2.

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución caracterizado por dificultades para relacionarse e interactuar con otras personas, le gusta estar en biblioteca para evitar los ruidos, se tapa los oídos ante los ruidos, se muestra tímida, inhibida, poca facilidad de contacto ha bajado el rendimiento académico, le cuesta relacionarse con los compañeros.

I. ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción: No reporta

Epilepsia: Tío paterno.

Autismo: Primo paterno.

TDAH: No reporta

Esquizofrenia: No reporta

II. ANTECEDENTES PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: Colon irritable a los granos.

Quirúrgicos: NO.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Paciente con adecuada presentación personal, alerta, adecuada higiene postural, orientada a lo y auto psíquicamente, tímida, inhibida, poca fluidez verbal, bradilalia, bradipsiquia, facilidad de contacto, no alteraciones de sueño, no alteraciones o quejas de memoria, no alteración en juicio y raciocinio, inteligencia aparentemente normal, no alucinaciones, no alteraciones de la conciencia.



ADOS 2	Fluidez verbal Niños y adolescentes
---------------	---

Afectación social (AS)

Comunicación

Narración de sucesos

(A-7)

2

2

Conversación

(A-8)

2

2

Gestos descriptivos, convencionales, instrumentales o informativos

(A-9)

1

1

Interacción social recíproca

Contacto visual inusual

(B-1)

2

0

Expresiones faciales dirigidas al examinador

(B-2)

2

2

Disfrute compartido durante la interacción

(B-4)

0

0

Características de las iniciaciones sociales

(B-7)

1

1

Calidad de respuesta social

(B-9)

1

1

Cantidad de comunicación social recíproca

(B-10)

1

1

Calidad general de la relación

(B-11)

1

1

TOTAL AS

11

Comportamiento restringido y repetitivo (CRR)

Comportamientos restringidos y repetitivos

Uso estereotipado o idiosincrásico de palabras o frases

(A-4)

0

0

Interés sensorial inusual en los materiales de juego o en las personas

(D-1)

0

0

Manierismo de manos y dedos y otros manierismos complejos

(D-2)

0

0

Intereses excesivos en temas u objetos inusuales o altamente específicos

(D-4)

0

0

TOTAL CRR

0

PUNTUACIÓN TOTAL GLOBAL (AS + CRR)

11

Clasificación para Autismo

9

Clasificación del Espectro autista

7



CONVERSIÓN DE LA PUNTUACIÓN TOTAL GLOBAL AL RANGO DE PREOCUPACIÓN DEL ADOS-2	
Rango de preocupación	Puntuación TOTAL GLOBAL mayor o igual que el punto de corte de <i>autismo</i> :
Autismo	Total global~ 9
	Puntaje total global igual o mayor al punto de corte
Espectro autista	≥ 7 pero ≤ 8
	Puntaje total global igual o mayor al punto de corte
No TEA	≤ 6
	Puntaje total global igual o menor al punto de corte

Observaciones según la aplicación del ADOS-2:

La evaluada proporciona información sobre hechos rutinarios y no rutinarios; sin embargo, depende en gran medida de las preguntas específicas del examinador para mantener la conversación. En ocasiones, describe situaciones poco espontáneas y con dificultad en el mantenimiento del hilo conversacional.

Se observa una limitada reciprocidad conversacional: La participante tiende a seguir su propio hilo de pensamiento más que involucrarse activamente en un intercambio bidireccional. Aunque ofrece información espontánea o realiza algunos comentarios, la sensación general de reciprocidad social es escasa para lo esperado para la edad de la paciente.

Presenta uso espontáneo de gestos descriptivos, aunque estos resultan exagerados, poco variados o se limitan a contextos específicos, a pesar de tener adecuado uso de las tareas simbólicas. Utiliza con mayor frecuencia gestos convencionales o instrumentales, pero el uso de gestos descriptivos es escaso o excepcional.

El contacto visual se encuentra pobremente modulado, dificultando iniciar, mantener o regular la interacción social. Muestra algunas expresiones faciales dirigidas al examinador, generalmente asociadas a emociones extremas; ocasionalmente expresa una gama más amplia de emociones.



Durante el intercambio interactivo o la conversación, manifiesta disfrute y participación emocional adecuados al contexto en más de una actividad o tema. Las iniciaciones sociales se presentan, aunque con características ligeramente inusuales.

La evaluada reacciona ante la mayoría de los contextos sociales, aunque sus respuestas pueden ser algo limitadas, socialmente incómodas, inapropiadas, inconsistentes o, en ocasiones, negativas. Se evidencia comunicación social recíproca, pero reducida en frecuencia, cantidad o variedad de contextos.

La interacción resulta agradable en algunos momentos, aunque no de forma sostenida, ya que en ocasiones se percibe artificial, mecánica o ligeramente inapropiada. No se observaron intereses restringidos, referencias a temas inusuales ni conductas repetitivas durante la sesión.

CUESTIONARIO DE EXPLORACIÓN DEL ESPECTRO DEL AUTISMO DE ALTO FUNCIONAMIENTO (ASSQ)
Resultado: 16
Punto de corte: 19 puntos en adelante.
NO TEA

Escala de Autismo Infantil (C.A.R.S.) Niños mayores de dos años	
Preguntas de la prueba	
I. REFERENTE A LA GENTE	4
II. IMITACION	2
III. RESPUESTA EMOCIONAL	4
IV. USO DEL CUERPO	0
V. USO DE OBJETOS	0
VI. ADAPTACION AL CAMBIO	4
VII. RESPUESTA VISUAL	4
VIII. RESPUESTA AUDITIVA	0
IX. RESPUESTA AL SABOR, OLOR, TACTO Y USO	0
X. MIEDO O NERVIOSISMO	0
XI. COMUNICACION VERBAL	4
XII. COMUNICACION NO VERBAL	4
XIII. NIVEL DE ACTIVIDAD	0
XIV. NIVEL Y CONSISTENCIA DE LA RESPUESTA INTELECTUAL	2
XV. IMPRESIONES GENERALES	1
RESULTADOS DE LA ESCALA DE AUTISMO INFANTIL (C.A.R.S.)	
RESULTADO: 29	Riesgo leve para TEA



Perfil cognitivo: Según la aplicación de las pruebas y observación clínica se obtiene un perfil de paciente con espectro del autismo con nivel de apoyo grado 1 o asperger desde la CIE 10, se observó fuga de ideas, disprosodia, detallismo en la interacción social, lo que limita la funcionalidad de la comprensión verbal, pocos gestos descriptivos, convencionales e instrumentales, el nivel de razonamiento de las cosas las hace desde otras perspectiva, se muestra muy noble, tímida, insegura, su comportamiento es inmaduro para la edad, logra responder preguntas pero tarda mas de lo esperado en procesar y responder, le cuesta establecer una conversación, pensamiento rígido, existe hiponimia, algunas muestras de juego simbólico pero no integrados, marcada dificultad en la interacción, socialización, comunicación, para iniciar una conversación, aunque es capaz de responder preguntas específicas, limitando la interacción con otras personas en diferentes contextos, existe disminución en interés, en emociones o afectos compartidos hasta fracasar en las interacciones sociales para la edad esperada, le cuesta ajustar su comportamiento a diversos contextos, puede tener mas miedos que otros niños a ciertas situaciones, con intereses particulares que alteran el funcionamiento personal, social, familiar y escolar.

La enuresis diurna se relaciona con un problema en la flexibilidad, anticipación, planificación aguantando las ganas de ir al baño hasta el ultimo momento, por lo cual se debe trabajar los reforzamientos diferenciales hasta logra la extinción de la conducta.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

F845 SÍNDROME DE ASPERGER (Trastorno del espectro del autismo grado 1).

PLAN DE TRATAMIENTO

Realizar adecuación y adaptación curricular: Implementación del plan Individual de apoyos y ajustes razonables (PIAR) [Subsección 3 Esquema de atención educativa - Artículo 2.3.3.5.2.3.5], por parte de la institución educativa, que permita favorecer el proceso de avance del - la niña(o) en sus aprendizajes escolares, y fomentar la motivación hacia los mismos. Lo anterior implica ajustar los logros y competencias al nivel del - la niña(o), estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que curse y mecanismos que permitan potencializar los aprendizajes mediante diferentes estrategias de evaluación de contenidos y logros acordes a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente.

Dar un trato digno.

1. Comunicación y apoyo social

- Fomentar interacciones estructuradas y guiadas con sus compañeros (por ejemplo, actividades en pareja o pequeños grupos con roles definidos).
- Promover el acompañamiento de un compañero guía o tutor empático que le ayude en la integración y comprensión de las dinámicas sociales.
- Evitar la exposición forzada en grupo o las actividades donde deba hablar sin preparación previa.



- Enseñar explícitamente habilidades sociales, como saludar, pedir ayuda, iniciar o mantener una conversación.

2. Procesamiento y tiempo de respuesta.

- Brindar tiempo adicional para procesar la información y responder a preguntas o consignas.
- Evitar presionarla para responder rápido; validar su ritmo de procesamiento.
- Dar instrucciones claras, concretas y paso a paso, verificando su comprensión.
- Utilizar apoyos visuales (imágenes, esquemas, rutinas) para facilitar la comprensión y anticipación de tareas.

3. Aspectos emocionales y conductuales

- Mantener un ambiente predecible y estructurado, informándole con anticipación sobre cambios o nuevas actividades.
- Reforzar positivamente sus logros, incluso los pequeños avances en interacción o participación.
- Evitar la burla o el señalamiento por parte de compañeros; fomentar la empatía y respeto dentro del aula.
- Propiciar espacios donde pueda expresar cómo se siente o qué necesita, usando si es necesario medios visuales o pictogramas.

4. Nivel de madurez y autonomía

- Asignar responsabilidades acordes a su nivel madurativo, evitando sobreexigirla.
- Promover rutinas claras para desarrollar hábitos de orden, autocuidado y cumplimiento de tareas.
- Incluir actividades que favorezcan la toma de decisiones simples para fortalecer su autoconfianza.

5. Coordinación interdisciplinaria y familia

- Mantener comunicación constante entre docentes, familia y terapeutas para unificar estrategias.
- Sugerir intervenciones de apoyo psicopedagógico o fonoaudiológico para fortalecer la fluidez verbal y la comunicación funcional.
- Evaluar la necesidad de ajustes curriculares no significativos, priorizando la comprensión sobre la cantidad de trabajo.



Utilice un tono de voz cordial, siempre, mantenga la calma, evite que las conductas escalen, sáquela de situaciones que la alteran, coloque un compañero que ayude las habilidades sociales por modelado.

Enseñe a sus compañeros que la estudiante necesita menos ruido para concentrarse, edúquelos acerca de algunas dificultades que pueden afectar su desempeño, esto la ayudara a ella y los hará a sus compañeros mejores personas.

Integrarla a las actividades, psico educar a los compañeros para lograr que apoyen la integración.

Apoye las clases desde lo motor y visual, será más fácil para aprender.

Contemple los días más desadaptativos, no se lo tome personal.

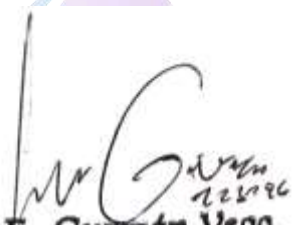
Respete su estilo y ritmo de aprendizaje.

Cree rutinas para cada día, visible donde pueda anticipar las actividades, agendas con fotos, pictogramas.

Apoye algunas clases con historietas, videos, cómics.

Explique la tarea por secuencia, paso a paso, apoyado en dibujos.

Elija un grupo de amigos que esté dispuesto a guiarle y a interactuar con ella.



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096
U.S.B. - Medellín

Firma

Nombre del Profesional: Jainer Enrique Guzmán Vega

Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad de San Buenaventura de Medellín.

No. Tarjeta Profesional:123096

